

Lipothymie, syncope et perte de connaissance brève

Interrogatoire. même valeur. Origines cardiaque/extracardiaque. Causes inconnues.

Syncope : PC subite, brève, avec impossibilité de maintenir la posture secondaire à une chute brutale du débit sanguin cérébral. Récupération spontanée de la conscience.

Lipothymie : la PC n'est pas totale (brouillard visuel, vertige).

Même valeur diagnostique que la syncope.

Diagnostic

➤ **Interrogatoire de la victime et de l'entourage: Etape essentielle du diagnostic**

✚ **Description de la crise**

- ❖ Brutale
- ❖ Brève < 3 min
- ❖ Avec chute + trauma
- ❖ Sans prodrome
- ❖ Sans confusion postcritique
- ❖ Sans convulsion, ni morsure de langue, ni urination

✚ **Circonstances de survenue** : effort, chaleur, tourner la tête,...

- ✚ **Syncope atypique** prolongée avec possibilité de **crise convulsive anoxique** avec morsure de langue et perte d'urines. De plus, la confusion post critique fréquente chez le sujet âgé.

➤ **Examen clinique :**

- ✚ **Prise de la TA couché-debout** rechercher une hypotension orthostatique
- ✚ **Auscultation cardiaque, et examen neuro complet**
- ✚ **Massage sino carotidien sous ECG** (s'assurer de l'absence de souffle carotidien)

➤ **Examens complémentaires :**

✚ **ECG, bilan biologique standard systématique** : NFS, glycémie, calcémie, kaliémie, GDS.

- ❖ Selon l'anamnèse:
- ❖ Tilt test ou test d'inclinaison
 - Examen à la recherche d'une hypertonie vagale
 - Decubitus dorsal pdt 10min puis inclinaison à 60° pdt 45 min en moy en surveillant pouls, cs, et TA : hypoTA et bradycardie.
 - Possible sensibilisation par utilisation de dérivé nitré mais Spé ↓.
 - Il est + ds 50 % des syncopes d'étiologie indéterminée après interrogatoire et clinique
- ❖ Holter ECG des 24 heures,, Exploration endocavitaire du faisceau de His, Stimulat° ventriculaire programmée
- ❖ Epreuve d'effort sauf si CMO / RAO, Echodoppler cardiaque et Coro
- ❖ EEG, TDM cérébral, Doppler des vx du cou.

Diagnostic étiologique

➤ **Syncopes d'origine cardiaque**

- ✚ **BAV complet et paroxystique** : syncope TYPIQUE brutale, sans prodrome, brève = accident d'Adams Stokes avec Ø pouls ou bradycardie sévère (< 20/min) percritique.
- ✚ **Autres troubles de conduction** : **dysfonction sinusale et BSA** (bradycardie sévère), **BAV du 2e degré**.
 - ❖ Diagnostic sur ECG per ou post critique (bloc biF, mobitz II) parfois grâce à l'exploration électrophysiologique du faisceau de His ou Holter-ECG.
- ✚ **Troubles du rythme surtout ventriculaires** : TV, torsades de pointes. Diagnostic par stimulation ventriculaire programmée si l'on suspecte une TV non documentée
 - ❖ Mais les tachycardies rapides supraventriculaires peuvent aussi entraîner une syncope **FA, FLUTTER, BOUVERET** (exceptionnel).
- ✚ **RAO et CMO** : syncopes d'effort, souffle systolique, Echo doppler
- ✚ **Causes plus rares** : **myxome de l'OG, thrombus sur prothèse valvulaire, angor syncopal de Prinzmetal, IDM, HTAP**
- ✚ **Syncope au lever ds Embolie pulmonaire**

➤ **Syncopes d'origine extracardiaque**

- ✚ **HypoTA orthostatique** : TA couchée puis dès le lever : **baisse de 30 mmHg** de TAs sans accélération réflexe du pouls (autres sources : ↓ TAs de 20 et ↓ TAd de 10 ?)
 - ❖ 2 étios : IDIOPATHIQUE (dysautonomie, parfois secondaire à un DS, Mie de Parkinson, ...) ou ttt médicamenteux chez un SA déshydraté.
- ✚ **Syncope vaso vagale** : **cause la plus fréquente de syncope**
 - ❖ circonstances de survenue (**chaud, stat° debout prolongé, postprandial, dl..**)
 - ❖ prodromes : nausée, sueurs, bâillement, fatigue+++
 - ❖ récupération progressive
 - ❖ Tilt test à la recherche d'une hypertonie vagale si doute.
- ✚ **Ictus laryngé à la toux**
- ✚ **Hyperreflexivité du sinus carotidien** :
 - ❖ **lors du rasage, col serré, rotation de la tête** chez un SA atheromateux
 - ❖ favorise compression des glomérules et dc : hypoTA et/ou bradycardie.
 - ❖ Massage sous ECG : positif si hypoTA ou pause cardiaque >3 sec.

Conséquence à un an :

✚ Etio cardioV :	25 % des syncopes	Mortalité à 1 an : 30 %
✚ Etio non cardioV :	25 %	10 %
✚ Ø etio déterminée :	50 %	5 %

Diagnostic différentiel

- **Pertes de connaissance d'origine neurologique**
 - ✚ **Epilepsie** : PC plus longue, mouvements tonico cloniques, morsure de langue et perte d'urines, confusion post critique. amnésie postcritique. Interet de l' EEG.
 - ✚ **Accident vasculaire cérébral** cause plus rare. Essentiellement **AIT vertebrobasillaire** avec drop-attack = dérochement brutal des MI => chute sans PCI.
- **Hystérie**
 - Contexte particulier, examen clinique normal, **belle indifférence**, **recherche de bénéfice secondaire**. Le plus svt **theatralisme** sans trauma lors de la chute.
- **Hypoglycémie ne donne pas de syncope vraie**
 - HypoG profonde donne une PC prolongé avec manif neurovegetative
- **Spasmophilie**
 - Tachycardie + polypnée + paresthésie buccale et des extrémités des MBs avec vécu angoissant
 - Spasmes musculaires favo par hyperventilation avec contracture MS.
 - NON GRAVE.
 - Le + svt bilan phosphomagnésioalcalique normal (hypocalcémie rare)
 - Ttt : Hypoventilation profonde ds 1 sac en plastique pdt 5 à 10 min.

Rappel

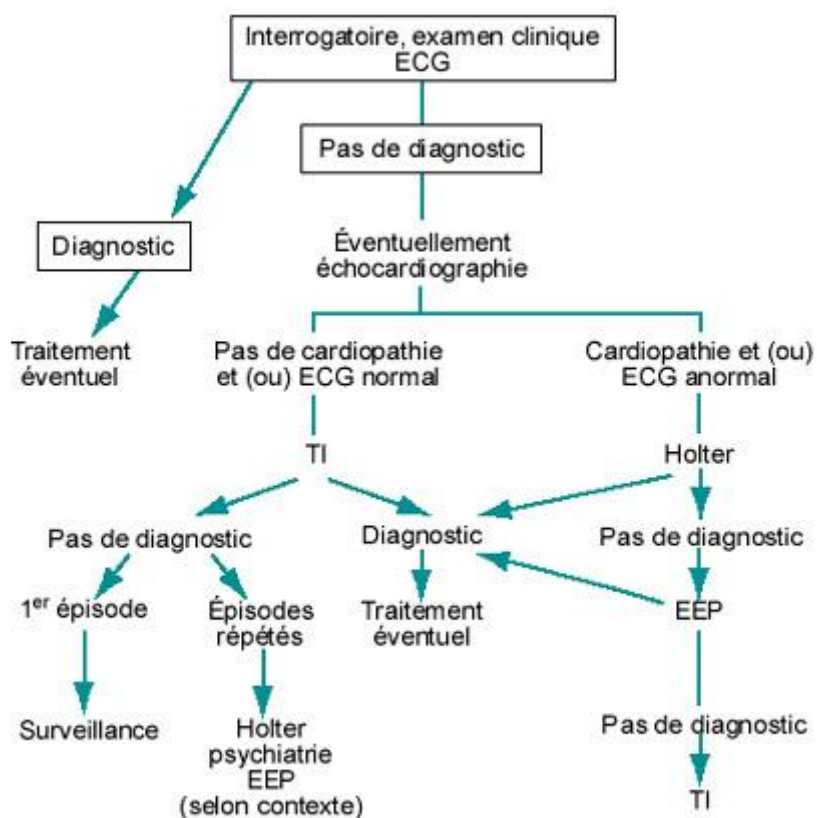
• Etiologies des syncopes d'effort

- **Obstacle à l'eject° du VG** :
 - Rao, CMO, Obstruction sur prothèse
- **Obstacle à l'eject° du VD** :
 - EP massive, HTAP primitive ou secondaire, Stenose pulmonaire sur cardiopathie congénitale
- **Obstacle au remplissage** :
 - Myxome OG (posturale ou chgmt posit°), Tamponnade
- **Dysplasie arythmogène du VD**

• Médicaments inducteurs d'une hypoTA orthostatique

- Par hypovolémie : diurétique, laxatif
- Par blocage de la réponse adrénergique à l'orthostatisme : β bloquant
- Par dépression de l'arc baroréflexe : antiHTA centraux, L-Dopa, Bromocriptine, psychotrope (NL)
- Par vasoD artérielle et veineuse ; Dérivé nitré

CAT devant une syncope



Source : Fiche RDP, RDP, KB cardio, Corpus Géria